



NOMBRE DEL ESTUDIANTE 4to SEMESTRE 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: PIELOPLASTIA

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

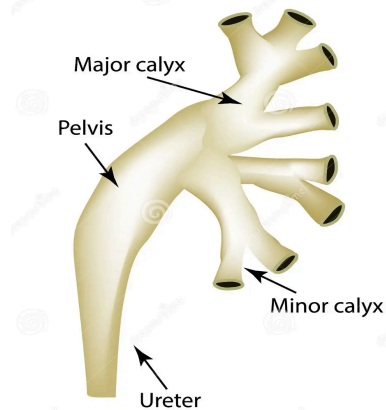
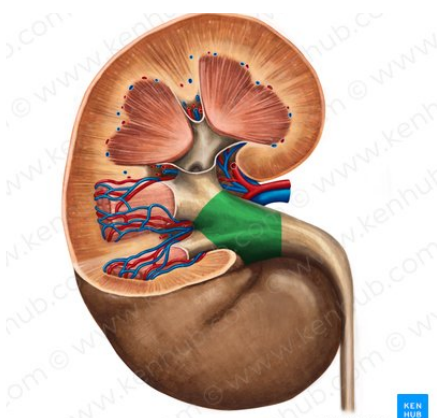
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

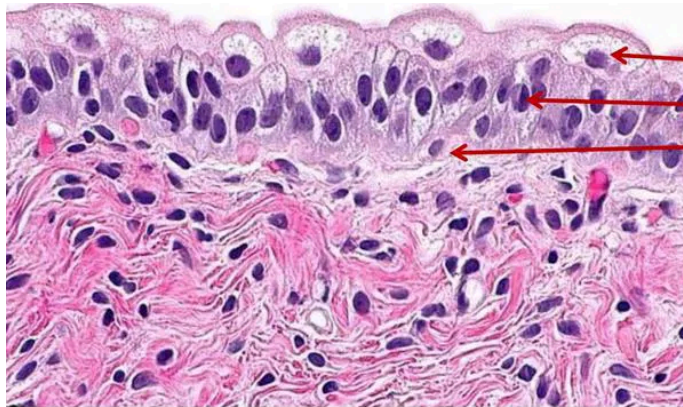
Resectar la porción estrecha de la unión pieloureteral para realizar una anastomosis que permita el adecuado paso de la orina desde el riñón hacia la vejiga por medio del uréter. En este procedimiento se expone el riñón más exactamente la unión pieloureteral a través de la fascia de gerota después se realiza la escisión del segmento estenosado y posteriormente se realiza colocación de un catéter doble J para finalizar con una anastomosis término terminal entre la pelvis renal y el uréter espatulado.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



La pelvis renal es una estructura anatómica del sistema urinario situada en el hilio del riñón, tiene forma de un embudo, con una amplia base que recibe la orina de los cálices mayores y una punta estrecha que se continúa con el uréter. Está compuesta por: cáliz mayor, cáliz menor y uréter.



EPITELIO:

Capa superficial

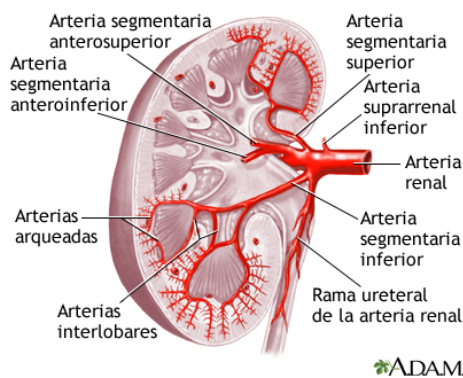
Capa celular intermedia

Capa celular basal



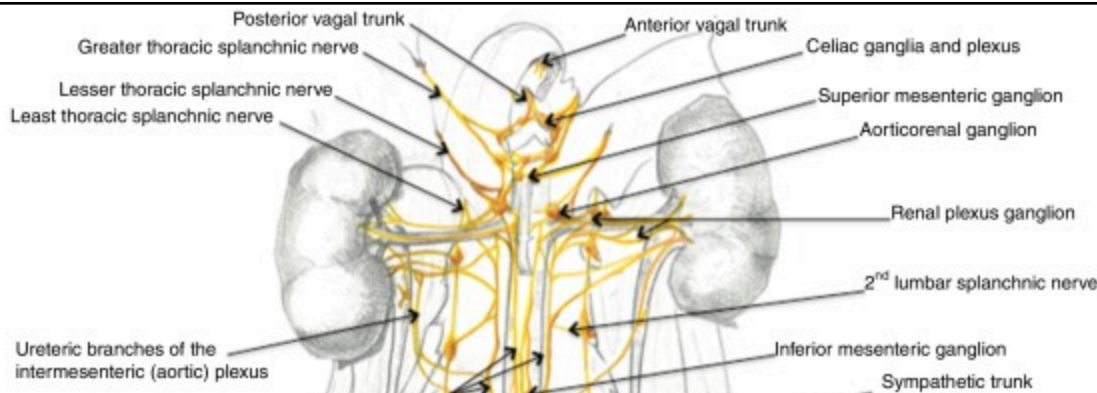
Estructuralmente está constituida por una mucosa, una túnica muscular lisa, dispuesta en una capa interna circular que ayuda en el movimiento de la orina hacia el uréter por medio de contracciones peristálticas y una capa externa longitudinal, y una adventicia. La pelvis renal está revestida por un epitelio de transición, llamado **UROTTELIO**, que es flexible y resistente a la orina.

IRRIGACIÓN



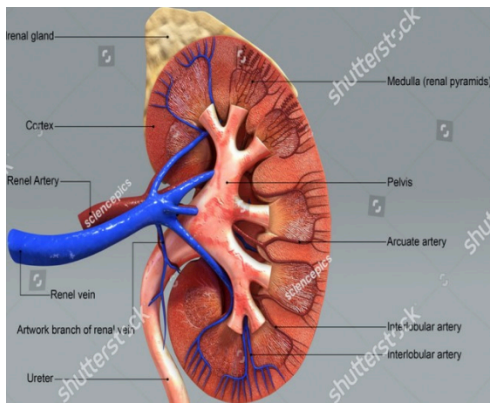
Se encuentra irrigado anteriormente por la Arteria Renal de manera posterior con la rama posterior que medialmente se prolonga hasta los vasos pre vertebrales, gonadal, iliaca común, vesical y uterina.

INERVACIÓN



Recibe innervación parasimpática de los nervios Esplénicos Pélvicos y del plexo hipogástrico inferior.

DRENAJE VENOSO

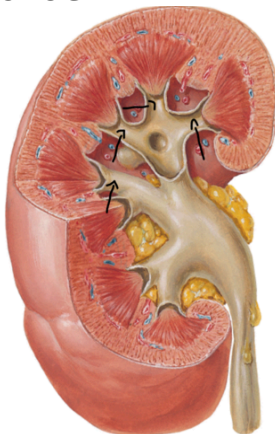


Su drenaje venoso consta de las ramas de la Vena Renal
La sangre de la pelvis renal drena hacia las venas renales, que luego desembocan en la vena cava inferior.
Los plexos venosos de la pelvis rodean los órganos pélvicos.

La mayoría de los plexos venosos desembocan en la vena ilíaca interna.

La vena ilíaca interna recibe afluentes de las venas rectal media, obturatriz, sacra lateral, glútea inferior y glútea superior.

FISIOLOGÍA



Su función principal es actuar como embudo que recoge la orina producida en el riñón y la dirige hacia el uréter, desde donde se transporta a la vejiga para su almacenamiento y posterior eliminación.

- **Recogida y canalización:** La orina producida en las nefronas se recoge en los túbulos colectores y luego se drena hacia los cálices menores. Desde allí, la orina fluye hacia los cálices mayores y finalmente a la pelvis.
- **Peristalsis:** Las contracciones peristálticas del músculo liso en la pared de la pelvis renal ayudan a propulsar la orina hacia el uréter.
- **Prevención del reflujo:** La anatomía de la unión pieloureteral (donde la pelvis renal se conecta con el uréter) ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los riñones, lo cual es esencial para evitar infecciones y daño renal.



- **Adaptabilidad:** El urotelio tiene la capacidad de expandirse y contraerse, permitiendo a la pelvis manejar diferentes volúmenes de orina sin sufrir daño.
- **Protección Inmunológica:** La pelvis renal posee una mucosa que actúa como barrera defensiva contra patógenos y sustancias tóxicas presentes en la orina.

1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
• Cistoscopio • Pinza de cuerpos extraños • Pinza de canastilla • Cámara • Lente de 30 • Fuente de luz	• Paquete de ropa general • Funda de mayo • Equipo de macrogoteo • Torre de endoscopio • Catéter doble J • Guías ureterales • Camisas ureterales • Sonda nelaton 8	• Piel: Polipropileno 3/0 ACC 3/8. Polidioxanona 4/0 ACC para niños. • Tejido celular subcutáneo: Poliglactin 910 3/0 ACR ½ círculo • Fascia - Músculo: Poliglactin 910 1 o 0 ACR ½ círculo • Pieloplastia: Poliglactina 910 4/0 – 5/0 ACR 1/2. Polidioxanona 4/0 – 5/0 ACR 1/2.	• Solución salina • Xilocaína de jalea

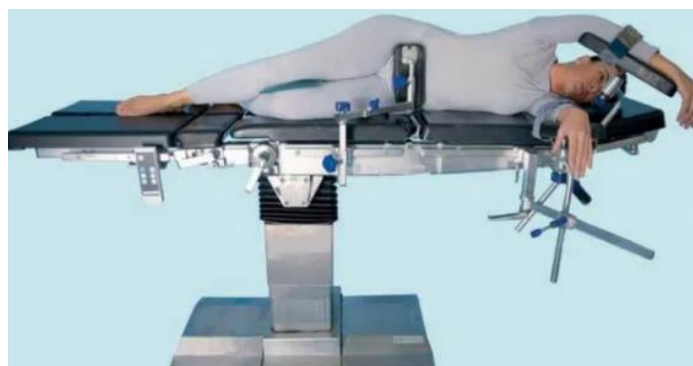


- **ETAPA DE ORGANIZACIÓN:**

- o Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):



DECÚBITO LATERAL



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



• **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

a) **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):**

- Anestesia General.

b) **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):**

- Se realiza incisión transperitoneal



c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se utilizan habitualmente 3 puertos (óptica dos operativos), pudiendo utilizar de forma opcional un 4º puerto

El paciente se coloca en decúbito lateral

Disección de la unión pieloureteral

Se realiza una incisión en el espacio parietocólico para desplazar el colon medialmente y se diseca el polo inferior del riñón y pelvis renal. Si se identifica un vaso polar, se diseca. Se debe liberar la pelvis renal y la unión Pieloureteral de todas sus adherencias adyacentes

Extirpación de la unión pieloureteral

Se secciona el uréter por debajo de la unión pieloureteral de forma oblicua para dejarlo espatulado en su borde superior. Se amplía con las tijeras hasta conseguir una espatulación de aproximadamente cm. En el caso de existir un vaso polar inferior, se moviliza a un plano posterior al que corresponderá a la anastomosis.

Se secciona longitudinalmente en sentido oblicuo el borde medial de la pelvis renal por encima de las estenosis ureteral para conseguir una apertura de al menos 1 centímetro

En el caso de pelvis muy redundantes se puede realizar una resección algo más amplia de la pelvis aunque se debe de tener cuidado en no resecar demasiado (una resección excesiva puede ocasionar un Acceso de la pelvis que dificulte su cierre posterior)

Sutura de la cara anterior de la unión pieloureteral

Para realizar anastomosis, se utiliza poliglicol 4-0. El primer punto se da de fuera adentro en el vértice inferior de la apertura piélica, pasándolo a continuación de dentro afuera por el vértice de la espatulación realizada en el uréter.

Este punto constituye en el extremo más caudal de la anastomosis a realizar y iniciándose a continuación una estructura continua en sentido proximal de la cara anterior de la anastomosis, pasando la aguja de afuera adentro en la pelvis y de dentro afuera en el uréter.

Este punto constituye el extremo más caudal de la anastomosis a realizar, iniciándose a continuación una sutura continua en sentido proximal de la cara anterior de la anastomosis, pasando la aguja de fuera adentro en la pelvis y de dentro a fuera en el uréter.

Colocación anterógrada del catéter doble J

Finalizada la sutura de la cara anterior, se introdujo un catéter doble J de forma anterógrada. Para ello se extrae por el puerto más craneal una guía metálica que es introducida retrógradamente a través del catéter colocado al inicio de la intervención



Sutura de la cara posterior de la unión pieloureteral

A continuación, se inicia pasando la aguja primero por la pelvis de fuera adentro y seguidamente por el uréter de dentro afuera

Finalizada la anastomosis ureteropielica, se introduce un Rendón número 14 por el trocar operativo más inferior. Se extrae los trocares cerrándose en los puertos correspondientes a los trocares de 10 mm

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**